



**Universidad
Norbert Wiener**
Powered by **Arizona State University**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela Académico Profesional de Enfermería

**“Calidad de atención de enfermería y su relación con la
satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que
acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña
Lima 2025”**

Proyecto de tesis para optar el título profesional licenciado en
enfermería

Presentado por:

AUTOR: Apolin Matos, Astrid Liliana

CÓDIGO ORCID:

AUTOR: Palma Rodriguez Aylin Tamara

CÓDIGO ORCID:

ASESOR: Mori Castro Jaime

Línea de Investigación

Salud y bienestar: Cuidados de enfermería

LIMA – PERÚ

2025

CAPITULO I: EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el 3, que está enfocado en la salud y bienestar, busca alcanzar la cobertura sanitaria universal. Esto implica que toda la población, y especialmente los niños, deben poder acceder a servicios sanitarios esenciales que sean integrales y se den con la calidad requerida. De cara al 2030, se insta a los países a erradicar el elevado número de muertes evitables en menores de 5 años, reduciendo significativamente la mortalidad infantil, lo cual es especialmente relevante en naciones con economías en proceso de desarrollo (1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que un aproximado de 144 millones de niños de menos de 5 años presentan en su condición de salud retraso en el crecimiento. Por esta razón, es crucial que asistan al de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para menores, el cual permite detectar de manera oportuna riesgos durante el crecimiento, desarrollo y posibles problemas de salud. El monitoreo de indicadores como el peso y la talla, entre otros, facilita la identificación temprana de un crecimiento inadecuado (2).

Un estudio hecho en Suecia que abordó satisfacción de los padres con la atención de sus hijos reveló que el 83% se declaró satisfecho o muy satisfecho. Sin embargo, alrededor del 6% expresó insatisfacción en cuanto a la comunicación durante la atención. Las posibles barreras que influyen en esta menor satisfacción podrían estar relacionadas con la falta de flexibilidad y eficacia en la comunicación entre los padres y los proveedores de salud (3).

Otro estudio realizado en Nigeria se reportó que un 72,2% de madres, tenían una percepción negativa sobre la atención brindada a sus hijos, mientras que solo un 27,8% la valoraban de manera positiva. Esto subraya la importancia de desarrollar programas que refuercen la calidad de la atención en salud, incluido los servicios enfermeros (4).

En Etiopía en 2022, un estudio señaló que la satisfacción de los cuidadores en la sala de pediatría fue del 68%. Los cuidadores se mostraron moderadamente satisfechos. El nivel de educación, la disponibilidad de instalaciones básicas para la comunicación con el cliente y la disponibilidad de análisis de laboratorio y medicamentos fueron factores que se asociaron significativamente con la satisfacción de los cuidadores (5).

En la zona de Asia, específicamente en Corea en 2021, se reportó que entre los factores que se asociaron a la opinión de las madres sobre la calidad de cuidados enfermeros se encontró la claridad en la comunicación del enfermero ($\beta=.44$, $p < .001$) y la relación establecida entre enfermero-madres ($\beta=.33$, $p = .001$). El poder explicativo total de estos factores fue del 54,1%. La calidad de la atención de enfermería en entornos pediátricos, está vinculada a las habilidades comunicativas del personal enfermero (6).

Un reporte realizado en la región latinoamericana, sobre tendencias recientes de las desigualdades en salud materna e infantil a través de encuestas nacionales, resalta que los avances a lo largo del tiempo y la magnitud de las desigualdades variaron según el país y el indicador. En el caso de los países e indicadores en los que los niveles de referencia eran elevados, como Argentina, Costa Rica y Cuba, los avances fueron lentos y las desigualdades fueron pequeñas en la mayoría de los indicadores. Los países que aún tienen margen de mejora, como Guyana, Honduras, Perú y Surinam, mostraron avances más rápidos en algunos indicadores, pero no en todos, aunque también presentaron desigualdades más amplias. En general se llama a la reflexión y acción por que aún persisten importantes desigualdades y se observan retrocesos en algunas áreas vinculados a servicios de salud esenciales (7).

Un estudio realizado en Colombia señala que solo un 23% de madres reportó baja satisfacción con la atención recibida del enfermero durante los controles rutinarios de sus hijos. El

estudio subraya la importancia de las habilidades demostradas por el personal de enfermería en la calidad de los cuidados ofrecidos (8).

En un estudio realizado en Cusco, Perú, en 2022 con 177 madres, reporto que un 13% de ellas informaron calidad moderada en la atención recibida y solo el 0,6% señaló calidad baja bajo. Asimismo, el 11,3% de madres refirió una conformidad moderada con la atención y un 0,6% que manifestó un bajo grado. Por lo tanto, se debe implementar programas de formación continua en atención al paciente para mejorar la calidad percibida y la satisfacción de las madres. Esto ayudará a elevar los niveles de atención, especialmente en aquellos casos donde la percepción no era la óptima (9).

En un estudio realizado en Puno, Perú, en 2023, con la participación de 109 madres, se informó que el 70% calificó la calidad de atención recibida como promedio, el 19% la demostró baja y un 11% la evaluó como alta. Respecto al nivel de satisfacción, un 86% de madres señaló satisfacción media, mientras que el 10% reportó una satisfacción baja y un 4% expresó un alto grado de satisfacción. Asimismo, se debe fomentar un enfoque más personalizado y empático en el trato hacia las madres, a través de la humanización de los servicios, puede contribuir a mejorar la percepción de calidad y satisfacción (10).

Haciendo una visita al Centro de Salud de Breña, se observa que hay una demanda importante en los consultorios de CRED. Temprano suele congestionarse dichos consultorios, ahí en muchos casos las madres que asisten con sus hijos tienen un tiempo de espera prolongado lo cual genera en ellos algo de disconformidad, tal como lo señala una madre que hacía cola durante la visita realizada. Una enfermera del servicio de CRED señala que “hay días en que falta personal para poder atender a un número importante de madres que acuden al servicio, de ahí que la congestión genera mayor tiempo de espera y un tiempo de atención muchas veces más corto, lo que dificulta el poder desplegar todas las actividades de valoración e intervención que deben realizarse según sea el caso”. Otra enfermera

resalta “que en estas situaciones es fundamental la gestión del servicio, en la cual el personal debe adecuarse a las circunstancias y limitaciones que se presenten”. En general es fundamental observar la atención de forma integral, desde que la madre hace cola en las inmediaciones del establecimiento de salud hasta que se retire de él.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es la relación de la calidad de atención de enfermería con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña, Lima 2025?

1.2.2 Problemas específicos

- ¿Cuál es la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión técnico - científica con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025?
- ¿Cuál es la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión humana con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025?
- ¿Cuál es la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión entorno con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Analizar la relación de la calidad de atención de enfermería con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña, Lima 2025.

1.3.2 Objetivos específicos

- Determinar la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión técnico - científica con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.
- Determinar la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión humana con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.
- Determinar la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión entorno con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Teórica

Se resalta de manera clara la relevancia del estudio y la contribución que puede hacer a la comprensión de la relación entre la calidad de atención enfermero y la satisfacción en madres. Se aportará conocimientos específicos para esta comunidad de participantes, abordando una posible brecha de conocimiento. Además, el uso del modelo de calidad de atención de Donabedian, el modelo SERVQUAL de Parasuraman y los aportes en el cuidado humanizado de Jean Watson y la valoración

del entorno de Florence Nightingale, reforzaran la solidez conceptual del estudio, proporcionando una estructura clara y enfocada tanto en los aspectos técnicos como en los humanos de la atención sanitaria. Estos aportes teóricos proporcionarán un marco robusto para interpretar los resultados, lo que permitirá identificar áreas de mejora en la atención del enfermero y contribuirá a aumentar conformidad de las madres con esta, todo ello apunta finalmente a que el menor este más cuidado y ello se refleje en su bienestar.

Este estudio es particularmente relevante debido a la escasez de antecedentes de investigación en el ámbito local, lo que justifica la necesidad de generar datos específicos sobre la experiencia de las madres en este contexto.

1.4.2 Metodológica

La presente investigación sigue los principios del método científico, brindando una estructura rigurosa y sistemática para abordar las etapas del proceso investigativo que conducirán a la obtención de resultados confiables. Este estudio es relevante y necesario, ya que se enfoca en un problema crucial para la atención primaria de salud, que afecta directamente la experiencia de las madres usuarias. La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo básico, con el objetivo de aportar nuevos conocimientos sobre los constructos abordados. El diseño del estudio es no experimental de tipo correlacional, dado que no se manipulan las variables, sino que se busca identificar la relación entre ellas en su entorno natural. Se emplearán dos instrumentos de medición, previamente validados y confiables, será un cuestionario para evaluar la primera y otra para la segunda variable. Estos instrumentos permitirán sistematizar información precisa y consistente, que será analizada para generar conclusiones útiles para el diseño posterior de mejoras en la atención CRED.

1.4.3 Practica

La importancia del estudio radica en su potencial para generar contribuciones prácticas que impacten de manera directa en la mejora de los servicios enfermeros en el Centro de Salud Breña, especialmente en los controles de CRED de menores de 3 años. Este estudio tiene relevancia en la implementación de estrategias que optimicen la atención de enfermería, mejorando la calidad del servicio y elevando la satisfacción de las madres. Entre las soluciones que se pueden derivar de este trabajo, se destaca la posibilidad de introducir medidas que refuercen la atención centrada en el usuario, como la mejora en la comunicación y el trato humanizado, elementos que son clave para aumentar la satisfacción de las madres.

Los hallazgos del estudio permitirán desarrollar intervenciones concretas, dirigidas a perfeccionar las prácticas de enfermería en la atención de los controles CRED. Estas mejoras no solo beneficiarán a las madres y sus hijos, sino también al personal de salud, al ofrecerles herramientas basadas en la evidencia que conlleve a cuidados eficientes y satisfactorios. Asimismo, los hallazgos podrán ser utilizados para guiar políticas de salud que fortalezcan la calidad del cuidado en centros de salud similares, asegurando un impacto que en la satisfacción de los padres y en el bienestar infantil.

1.5 Delimitación de la investigación

1.5.1 Temporal

El estudio será ejecutado en el último semestre del año 2025, en los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

1.5.2 Espacial

La investigación tendrá lugar en el Centro de Salud Breña, localizado en Lima.

1.5.3 Población o unidad de análisis

Lo conforman las madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden al ambiente donde se hace el control de CRED.

CAPITULO II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes

2.1.1 Antecedentes internacionales

Kruszecka y col., (11), en el 2021, en Polonia, con el objetivo de "Examinar los predictores seleccionados de la satisfacción de los padres con la atención de enfermería". Estudio transversal, descriptivo. Muestra de 1030 informantes. Método cuantitativo. Se les fue administrado un cuestionario para satisfacción. Resultado, encontró que un 76% de los padres reportaron alta satisfacción general con la atención de enfermería ($Q2=4,55$; $Q1=4,02$; $Q3=4,89$). La puntuación más baja, aunque aún positiva, se observó en la categoría de Participación de los Padres, donde el 72% de los encuestados se mostraron muy satisfechos. En resumen, los padres informaron alta satisfacción general con los servicios de enfermería.

Adawudu (12), en 2024, en Ghana, hizo un estudio con el objetivo "Evaluar la satisfacción de los padres con la atención de enfermería proporcionada a los niños en una unidad pediátrica". Estudio fue transversal, descriptivo. Muestra de 238 padres. Método, utilizó un cuestionario para valorar la satisfacción. Resultado, el 60,1% de informantes estuvieron satisfechos con la atención del enfermero. Además, los padres con mayores expectativas tenían una mayor probabilidad de expresar satisfacción con la atención ($ORa=1,4$, IC 95%: 1,24-1,57). En resumen, la satisfacción general de los informantes con la atención del enfermero fue ligeramente superior al promedio.

Ojewale y col., (13), en 2022, en Nigeria, realizaron un estudio con el objetivo "Analizar la percepción de los cuidadores respecto a la calidad de la atención de enfermería en los servicios de salud infantil". Estudio, fue transversal, descriptivo. Muestra, 308 participantes. Método, les administró un cuestionario para recoger datos. Resultados, la “preocupación y cuidado de las enfermeras”, el “reconocimiento de las necesidades de los cuidadores”, la “coordinación de la atención” y la

“privacidad” fueron percibidos como adecuados por el 50,2%, 54,9%, 56,3% y 57% de los cuidadores, respectivamente. En contraste, la “claridad de las instrucciones”, la “disposición a ayudar” y la “competencia y habilidades” fueron evaluadas positivamente por el 61,7%, 56,3% y 63,8% de los encuestados. En conclusión, la opinión de los cuidadores sobre la atención del enfermero fue considerada como regular en general.

Persigue y col., et al. (14), en 2023, en Ghana, hicieron un estudio con el objetivo “Analizar la satisfacción de los clientes con la atención sanitaria infantil prestada en el Hospital Universitario de Tamale”. Estudio transversal. Participaron 385 padres. Método cuantitativo. Se aplicó un cuestionario para la valoración de la variable principal. Resultados, el primer factor de satisfacción más importante para la calidad del servicio de atención sanitaria del cliente es la tangibilidad, con un IRI de 1,20, y el factor menos valorado es la prioridad y la capacidad de respuesta, con un IRI de 0,40, respectivamente. En conclusión, la afluencia de los servicios de atención de salud infantil en los centros de salud es generalmente alta.

Madero y col., (15), en 2023, en Colombia, hicieron un estudio con el objetivo “Valorar la percepción de madres sobre la atención de enfermería en CRED”. Estudio transversal. Muestra, 604 madres. Método, aplicó un cuestionario para percepción de la atención. Resultados, la satisfacción general fue alta con 77%, debido a la habilidad mostrada por el enfermero en CRED. En el dominio humano se obtuvo 76%, en oportuno 78%, continuo 72% y seguro 71%. En resumen, las habilidades del enfermero garantizan la adherencia de las madres a las sugerencias que se les brinden en favor del menor.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Huaytalla (16), en el año 2022, realizó un estudio con el objetivo "Analizar la calidad del cuidado proporcionado por el personal de enfermería y la satisfacción de las madres con niños menores de tres

años". Estudio correlacional. Muestra 80 participantes. Método, administró dos instrumentos de evaluación. Resultado, un 77,5% de los encuestados percibió una calidad de cuidado alto, mientras que el 22,5% consideró que fue moderada. Respecto a satisfacción, el 90% de informantes reportó satisfacción alta, y el 10% manifestó un nivel medio. Se concluye, que hubo relación entre ambos constructos centrales.

Sánchez (17), en el año 2022, hizo un estudio en Trujillo, Perú, realizó un estudio con el objetivo "Analizar la calidad de atención brindada por el personal de enfermería y la satisfacción de las madres que acuden al servicio de CRED con sus hijos menores". El estudio, de diseño correlacional. Muestra 136 madres informantes. Método, se administró dos instrumentos para valorar las variables en cuestión. Resultado, el 63,97% de las madres percibió una calidad buena, el 33,9% regular, y el 2,94% deficiente. En cuanto a la satisfacción, el 75% reportó un alto nivel de satisfacción, el 22,06% manifestó una satisfacción media, y el 2,94% refirió un bajo nivel de satisfacción. En conclusión, hubo relación significativa entre ambas variables ejes del estudio.

Montiel y Salcedo (18), en el año 2022, en Apurímac, Perú, realizaron un estudio con el objetivo "Analizar la calidad de atención brindada por el personal de enfermería y la satisfacción de las madres". Estudio, correlacional. Muestra de 251 madres. Método, se administró dos cuestionarios. Resultado, un 57,2% reportó atención media, el 30,3% consideraron que la atención carece de calidad, y el 12,5% opinaron que la atención buena. En cuanto a la satisfacción, el 47,4% de las madres se sintieron moderadamente satisfechas, el 41,4% expresaron insatisfacción, y el 11,2% se declararon satisfechas. Se concluye que hubo relación entre los constructos centrales del estudio.

Castro (19), en el 2023 en Perú, llevó a cabo un estudio con el objetivo "Evaluar la calidad de atención y satisfacción de usuarios de CRED en Ancash". Estudio, correlacional. Muestra de 81 informantes. Método cuantitativo, se administraron dos cuestionarios, uno para cada variable. Resultados, hubo un 55,6% con atención media, 23,5% con atención baja y 21% con atención baja. Un 59% tuvo

satisfacción media, 28,4% alta y 12,3% baja. En resumen, se encontró relación entre ambas variables centrales del estudio ($p < 0,05$).

Sinche (20), en 2023 en Perú, llevo a cabo un estudio con el objetivo “Valorar la calidad de atención enfermero y su relación con la satisfacción en madres de CRED del Hospital Cayetano Heredia”.

Estudio, correlacional. Muestra de 82 informantes como muestra. Método cuantitativo, se administraron dos cuestionarios, uno para cada variable. Resultado, en calidad de atención tuvo mayor frecuencia el valor regular con 78%, en satisfacción tuvo más frecuencia el valor regular con 85,4%. En resumen, hubo relación entre ambas variables centrales del estudio ($p < 0,05$).

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Calidad de atención

Definición

Se refiere al conjunto de características de los servicios de salud que aseguran que el cuidado proporcionado a los pacientes sea seguro, efectivo, eficiente, accesible, equitativo y centrado en el paciente. Según la OMS, la calidad de atención implica brindar servicios de salud que incrementen las probabilidades de obtener los resultados deseados para el paciente, de acuerdo con el conocimiento médico actual, y que sean consistentes con los valores y expectativas de quienes los reciben (21).

Generalidades

Donabedian, plantea en términos generales que la calidad de atención permite alcanzar objetivos deseables empleando medios legítimos. También resaltar que “calidad” no es un constructo específico de la atención sanitaria, ya que es utilizado en diversos sectores de la sociedad. La gente utiliza el término calidad cuando describe una serie de aspectos positivos en los servicios que consume (22).

La percepción de los pacientes sobre la calidad de la atención recibida está fuertemente influenciada por el trato y la relación que establecen con el personal de salud. Este enfoque centrado en la persona no solo mejora los resultados clínicos, sino que también incrementa la satisfacción y confianza del usuario con el sistema de salud. La evaluación continua y el compromiso por mejorar la calidad en salud son esenciales para alcanzar un sistema de salud que pueda atender las necesidades de salud y resolver los problemas de salud que aquejan a la población. La valoración de procesos e indicadores son pilares en la gestión de la calidad (23).

2.2.2 Calidad de atención de enfermería

Definición

Abarca el conjunto de acciones, procedimientos y cuidados que los profesionales de enfermería brindan con el fin de prestar cuidados ante las necesidades de los pacientes. Se evalúa mediante indicadores como la seguridad, la efectividad, la eficiencia, la equidad y el enfoque en el paciente, garantizando que la atención se proporcione de forma segura, basada en la evidencia científica y en un entorno de confianza y respeto. Un componente crucial es la habilidad del personal de enfermería para evitar errores, disminuir riesgos y asegurar la continuidad en la atención brindada (24).

Asimismo, la calidad en la atención está profundamente ligada a la satisfacción/conformidad del paciente, donde elementos como la empatía, una comunicación efectiva y oportuna, y el trato respetuoso hacia el paciente son determinantes. Estos aspectos aparte de influir en la opinión del paciente sobre los cuidados recibidos fortalecen su confianza en el equipo de salud, contribuyendo a mejores resultados en su atención. La calidad en atención no solo impacta en los resultados de salud, sino también en la percepción del paciente sobre el trato recibido, influyendo en su bienestar emocional y en su experiencia general dentro sistema de salud (25).

Dimensiones de calidad de atención de enfermería

-Técnico-Científica

Esta referida a como son aplicados los conocimientos científicos y habilidades técnicas en el cuidado de los pacientes. Abarca la correcta ejecución de procedimientos clínicos, la utilización de equipos médicos, y el tomar decisiones en base a la evidencia científica disponible. El objetivo principal es garantizar que los cuidados sean seguros, eficaces y apropiados para las condiciones de salud del paciente, siguiendo protocolos y guías clínicas establecidas que optimicen los resultados de salud. En cuanto a este estudio incluye la valoración antropométrica del menor, velar por su progreso, su valoración en lo físico y lo psicomotriz, educación integral, gestión de interconsultas y garantizar un control continuo, todo ello debe ser realizado dentro del marco organizacional institucional (26).

-Humana

Hace énfasis en la búsqueda de una adecuada relación interpersonal entre enfermero con el usuario, ello esta caracterizado por la empatía, el respeto y la comprensión. Esta dimensión valora al ser humano no solo como un receptor de cuidados técnicos, sino como una persona con necesidades emocionales, psicológicas y sociales. La comunicación clara y efectiva, así como respetar la dignidad y las creencias del usuario, son fundamentales para generar confianza y seguridad, mejorando su experiencia al momento de la atención (27).

En este punto se debe actuar con seguridad, brindando cuidados integrales, basados en el respeto y una óptima comunicación, mostrando siempre el interés por resolver las necesidades de los pacientes, todo dentro de un trato directo y cortés. El humano del cuidado promueve la personalización en la atención, adaptándose está a las necesidades específicas de cada individuo. Este enfoque considera el entorno del paciente, sus valores, creencias y experiencias, brindando un cuidado más cercano y significativo. En esencia, el cuidado humano busca humanizar la práctica realizada por el enfermero, lo cual impactara

positivamente en el bienestar del paciente. Su enfoque holístico también favorece que el paciente se sienta conforme con el trabajo desplegado por el profesional enfermero (28).

-Entorno

Son las condiciones físicas, ambientales y organizacionales en las que se brinda la atención de salud. Un ambiente adecuado incluye aspectos como la higiene, la seguridad, el confort, y la privacidad del paciente, factores que influyen directamente en su bienestar y recuperación. Además, un entorno bien gestionado facilita el trabajo del personal de enfermería y reduce los riesgos de infecciones y errores, contribuyendo a una atención más segura y eficaz (29).

Existe un vínculo indivisible entre el medio ambiente y nuestra salud. Este vínculo, tejido con hilos de complejidad, va a interconectar el tejido de nuestro bienestar con los ecosistemas que están alrededor del individuo. El entorno en un establecimiento de salud tiene un impacto profundo en la atención brindada a los usuarios. Contar con espacios amplios, adecuados, limpios, ordenados y que den confort crean un ambiente propicio para la atención y recuperación, disminuyendo la ansiedad, estrés e impaciencia de los pacientes. Un aspecto importante es el control del ruido, la iluminación adecuada y la ventilación, elementos que no deben dejarse de lado, ya que se asocian con experiencias positivas. En muchos casos, un entorno bien diseñado también contribuye a reducir complicaciones, como infecciones nosocomiales o accidentes en los servicios. Además, los ambientes que promueven la privacidad favorecen que fluya una comunicación más efectiva entre pacientes y profesionales, fortaleciendo la relación terapéutica e incrementando así los niveles de satisfacción. Finalmente hay que señalar que un entorno adecuado no solo beneficia al usuario, sino que también tiene repercusiones directas en el desempeño del personal sanitario (30).

2.2.3 Satisfacción de las madres

Definición Se refiere a la percepción y valoración que las madres tienen sobre la calidad del cuidado recibido para ellas o sus hijos. Esta satisfacción está influenciada por varios factores, como la atención técnica y humana proporcionada por el personal de salud, la empatía, la comunicación efectiva, el respeto por sus necesidades y preocupaciones, y la respuesta oportuna a sus expectativas durante el proceso de atención (31).

La satisfacción también refleja cómo el usuario percibe aspectos como el ambiente físico, la organización y eficiencia en la atención, y el grado en que sienten que sus derechos y decisiones son respetados. Una alta satisfacción está asociada a una experiencia positiva, lo que contribuye a una mayor adherencia a los cuidados recomendados y una mejor relación con los profesionales de salud (32).

Dimensiones de satisfacción de las madres

-Accesibilidad

Hace referencia a la facilidad que tiene el paciente, para acceder a los servicios sanitarios. Las madres y sus hijos deben poder acceder a los servicios de salud cuando los necesitan. Esto implica contar con recursos disponibles, además de no tener barreras en lo geográfico, económico, administrativo o cultural que dificulten el poder acceder a los servicios, así como la adaptación de horarios, procesos y atención de necesidades en general, especialmente de los más vulnerables (33).

-Confort

Hace referencia al bienestar físico y emocional del paciente mientras recibe atención. En el caso de las madres, incluye aspectos como la comodidad de las instalaciones, la privacidad durante la atención, la

tranquilidad emocional proporcionada por un ambiente respetuoso y la minimización del dolor o la incomodidad durante los procedimientos. El confort es crucial para generar experiencias positivas en los usuarios y contribuir a su recuperación, para ello el ambiente donde se atiende debe ser óptimo, seguro y debe permitir el resguardo de la intimidad del paciente (34).

El confort asociado a los cuidados de enfermería involucra componentes físicos, psicoespirituales, ambientales y socioculturales; todos en conjunto expresan una mirada holística de este constructo bastante mencionado y aplicado en la práctica del cuidado. Se plantea que el confort es un estado en el que se satisfacen diversas necesidades de la persona. Se destaca que el rol del enfermero es identificar qué tipo de apoyo requiere cada paciente y proporcionar ante ello intervenciones adecuadas para aliviar el malestar, generar calma y favorecer experiencias positivas. El centrarse en mejorar el confort del paciente, permite brindarle más bienestar general, lo que contribuye significativamente a su recuperación (35).

-Mantiene relación de confianza

Esto implica establecer una comunicación clara (la comunicación eficaz es uno de los pilares de la función del enfermero), transparente y respetuosa, donde las madres se sientan escuchadas y valoradas. La confianza se construye a través de la empatía, la honestidad y la consistencia en la calidad del cuidado. Una relación de confianza es fundamental para que las madres sigan las recomendaciones de salud, compartan sus preocupaciones y se sientan seguras en el entorno de atención (36).

Este tipo de comunicación entre enfermero y usuario es un pilar fundamental en la atención de salud. Cuando se establece una relación basada en la empatía, la escucha activa y respeto, el paciente se siente valorado y comprendido, ello repercute en que este tenga mayor apertura y coopere. Esta confianza se consigue con una adecuada comunicación efectiva, ello facilita el intercambio de información decisiva, lo que permite al enfermero comprender mejor las preocupaciones y necesidades de los usuarios (37).

2.2.4 Controles de CRED

Los Controles de CRED es gestionado por el personal enfermero, va a comprender un conjunto de evaluaciones periódicas que se realizan a los niños desde que nacen hasta los 5 años, con el objetivo de monitorizar su crecimiento, desarrollo y estado de salud general. Durante estos controles, el profesional de salud verifica el estado nutricional del niño, administra vacunas, evalúa el desarrollo psicomotor, identifica signos de enfermedades o problemas de salud y orienta a los padres sobre cuidados preventivos y promoción de hábitos saludables. Es una parte importante de la atención del primer nivel, que se enfoca en promover la salud y la prevención (38).

CRED es una estrategia de salud que involucra controles de niños, específicamente centrada en evaluar y promover el crecimiento y desarrollo integral del niño. En este control, se mide el peso, talla, perímetro cefálico y otros indicadores del desarrollo físico y neurológico del niño, así como la identificación temprana de riesgos o trastornos en el desarrollo. Además, el CRED incluye el seguimiento del estado nutricional, la vigilancia de enfermedades prevenibles mediante vacunas y la promoción de conductas saludables. Ambos conceptos son esenciales para asegurar el bienestar infantil y prevenir futuros problemas de salud (39).

Se destaca la importancia del enfoque colaborativo en los controles CRED, ahí los profesionales de enfermería deben trabajar junto con los padres y otros proveedores de salud para garantizar el bienestar general del menor, promoviendo una atención centrada en la familia, ya que el entorno familiar es el espacio donde el niño se desenvuelve y desarrolla (40).

2.2.5 Teorías vinculadas al tema

Teoría de calidad del entorno de Florence Nightingale (1859)

La autora sentó las bases de la enfermería científica moderna. Acá se la importancia de contar con un entorno adecuado para poder recuperar óptimamente a los pacientes se enfatiza en la higiene,

ventilación, iluminación apropiada, entre otros aspectos; teniendo las condiciones adecuadas, los procesos de atención y cuidados podrán cumplir con las metas de que el paciente evoluciones más favorablemente y encontrar mejores resultados de salud para ellos. En el contexto de la atención y cuidados brindados en los controles de niños sanos que se viabilizan en los consultorios de CRED, los aportes de Nightingale pueden aplicarse al asegurar que los espacios donde se presta atención a los niños sean los idóneos, es decir sean adecuados en tamaño, estén limpios, estén iluminados y ventilados, estén decorados e implementados para desarrollar las actividades con los menores, etc. (41).

Teoría del Cuidado Humanizado de Jean Watson

La autora es una enfermera teórica emblemática, que continúa aportando con sus propuestas a enriquecer la ciencia del cuidado. El cuidado de una persona debe ser integral, es decir ver sus dimensiones en su totalidad, donde se comprenda el cuidado de lo físico, emocional, social y espiritual, ya todo ello influye en la recuperación del paciente. El enfermero debe generar un ambiente de cuidado de respeto mutuo, facilitando así que surjan relaciones humanas más profundas y significativas. En el contexto del Control de CRED, el niño acude con su madre, por ello la atención integral debe involucrar a ambos, niños y sus madres (42).

Calidad de atención en salud de Avedis Donabedian

Fue un médico de origen libanés que luego paso a residir en Estados Unidos, apporto el modelo de calidad de atención en salud diseñado en 1966. Este es considerado como una de las propuestas teóricas más influyente que permitió trabajar en la valoración y mejora de la calidad de los servicios de salud. En su propuesta, se señala que la atención en salud puede ser evaluada a través de tres pilares centrales: estructura, proceso y resultados. La estructura esta referida a todos los recursos con que se dispone, como infraestructura, equipos y el recurso humano; el proceso enfatiza en las actividades y prácticas a ser realizadas durante las atenciones; y los resultados se enfocan en cómo evoluciona el

estado de salud de los usuarios, incluyendo el tener más salud, estar más satisfecho con la atención recibida y el tener mayor bienestar (43).

Modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988)

Plantean la importancia de considerar la opinión de los usuarios, ello contribuye a comprender mejor como es que se da la dinámica de atención. El modelo está basado en valorar el servicio recibido, que parte de las expectativas que tenía antes de recibirlo. A través de esta valoración se pueden identificar las brechas e inconsistencias que traban el proceso de atención que debe ser fluido. Se establece que la satisfacción puede evaluarse a través de cinco aspectos: La fiabilidad, que enfatiza en la capacidad de dar un servicio confiable y preciso; la capacidad de respuesta, que enfatiza en la disposición y prontitud del recurso humano para orientar y resolver inquietudes de los usuarios; la seguridad, que enfatiza en la confianza y seguridad que se transmite a los usuarios (44).

2.3 Formulación de hipótesis

2.3.1 Hipótesis general

-Hi: Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

-Ho: No existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

2.3.2 Hipótesis específicas

-Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión técnico - científica y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de niños sanos en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

-Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión humana y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

-Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión entorno y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

CAPITULO III. METODOLOGIA

3.1 Método de la investigación

En este estudio se adopta el método hipotético-deductivo, uno de los enfoques más utilizados en la construcción del conocimiento científico. Este método consiste en desarrollar un modelo teórico a partir de hipótesis formuladas a partir de observaciones previas, y luego algunas de esas hipótesis a prueba, deduciendo sus posibles implicaciones. Las hipótesis, que representan afirmaciones o preguntas susceptibles de verificación, guían el proceso de investigación. El enfoque comienza con interrogantes generales que, tras ser algunas a prueba, son aceptadas o rechazadas, lo que permite alcanzar conclusiones más precisas (45).

3.2 Enfoque de la investigación

El enfoque que se asume es el cuantitativo, ya que este permite medir y cuantificar la magnitud del problema mediante el uso de instrumentos específicos, seguido de un análisis numérico utilizando técnicas estadísticas (46).

3.3 Tipo de investigación

Es de naturaleza básica, ya que busca aportar evidencia científica que ayude a expandir el conocimiento en un área específica. A diferencia de la investigación aplicada, la investigación básica se concentra en profundizar en aspectos teóricos sin la intención de generar aplicaciones prácticas inmediatas. Generalmente se desarrolla en contextos académicos o de laboratorio, donde se exploran principios, teorías y conceptos abstractos. Su finalidad es comprender fenómenos esenciales, proporcionando una base sólida para estudios aplicados en el futuro (47).

3.4. Diseño de la investigación

El estudio en cuestión es de carácter no experimental, ya que no se realiza manipulación de variables ni se ejerce control sobre el proceso. Se busca observar y analizar el fenómeno en su entorno natural, lo que permite cuantificarlo y extraer conclusiones relevantes para la investigación (48).

3.5. Población, muestra y muestreo

3.5.1 Población

En este estudio se ha previsto contar como población a las madres de niños menores de 3 años atendidos en el establecimiento ubicado en Breña. Para el cálculo poblacional, se obtuvo información del equipo de gestión del servicio de CRED, que señalan un promedio, que acuden mensualmente al servicio, que son 150 madres con niños menores de 3 años para los controles de niños sanos (promedio de los últimos 4 meses). Con el objetivo de homogeneizar las características de todas las madres participantes y asegurar la validez del estudio, se han establecido criterios de inclusión y exclusión específicos. Estos criterios fueron elaborados previamente para garantizar que los participantes compartan características comparables. Los criterios se fueron elaborados previamente, estos se enuncian seguidamente:

Criterios de inclusión

- Madres de niños menores de 3 años que acuden al servicio de control CRED en el Centro de Salud en Breña.
- Madres que aceptan participar voluntariamente en el estudio mediante la firma de un consentimiento informado.
- Madres con asistencia regular a CRED en el establecimiento de salud.

Criterios de exclusión

- Madres con menores con condiciones de salud crónicas o complejas.
- Madres que no acuden regularmente a los controles de CRED.
- Madres que señalen no querer ser parte del estudio.

3.5.2 Muestra

El tamaño muestral se efectuará aplicando la fórmula estadística diseñada para poblaciones finitas, a partir de la cual se obtiene el cálculo requerido.

$$n = \frac{N * Z_a^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_a^2 * p * q}$$

n: Muestra = 108,08

N: Tamaño de la población = 150

Z: Nivel de confianza = 1,96

e: Error de estimación máximo = 5%

p: Probabilidad de éxito = 50%

q: (1-p) Probabilidad de fracaso = 50%

Realizando el cálculo respectivo, la muestra está dada por 108 madres informantes.

3.5.3 Muestreo

El tipo de muestreo que se aplicará no será probabilístico, seleccionando a las madres informantes por conveniencia. Esto significa que se incluirán en el estudio conforme se tenga acceso a ellas, hasta alcanzar el tamaño de muestra previamente establecido.

3.6. Variables y operacionalización

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa (niveles o rangos)
Calidad de atención de enfermería	Es el grado en que la atención proveída por el profesional de enfermería incrementa la posibilidad de alcanzar resultados de salud más favorables para los pacientes (49).	Es el grado en que la atención proveída por el profesional de enfermería incrementa la posibilidad de alcanzar resultados de salud más favorables para las madres, lo cual será valorado con el cuestionario de calidad de atención de enfermería.	Técnico - Científica	-Valoración de peso/talla -Reporte de progreso del niño -Valoración física -Valoración psicomotriz -Educación integral -Interconsultas a otras especialidades -Control continuo	Ordinal	Alta (Puntaje 82 a 110)
			Humana	-Seguridad -Atención integral -Respeto -Comunicación -Interés		Media (Puntaje 52 a 81)
			Entorno	-Comodidad/confort -Ambiente adecuado -Higiene -Armonía -Privacidad		Baja (Puntaje 22 a 51)
Satisfacción de madres	Es el grado de conformidad del usuario con respecto a la calidad de la atención sanitaria que recibe (50).	Es el grado de conformidad de las madres con respecto a la calidad de la atención sanitaria que recibe, lo cual será valorado con el cuestionario satisfacción de madres.	Accesibilidad	-Solidez científica. -Empatía. -Atención oportuna	Ordinal	Alta (Puntaje 82 a 110)
			Confort	-Consultorio óptimo. -Consultorio seguro. -Respeto a la intimidad.		Media (Puntaje 52 a 81)
			Mantiene relación de confianza	-Asesoramiento integral. -Amabilidad. -Convicción.		Baja (Puntaje 22 a 51)

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

Sera aplicada la encuesta, la cual es ideal para investigaciones cuantitativas en el ámbito de la salud. Esta herramienta es la más propicia y conveniente por su practicidad en su aplicación, lo que la convierte en un recurso apropiado para el desarrollo de la actividad de campo. Su flexibilidad y capacidad de adaptarse a diferentes escenarios de investigación son características clave. Además, la estandarización de la encuesta permite recolectar grandes cantidades de información en poco tiempo. A través de esta técnica, es posible recopilar las opiniones y percepciones de los participantes sobre el tema de interés del investigador (51).

3.7.2. Descripción de instrumentos

Cuestionario de calidad de atención de enfermería

El cuestionario, fue desarrollado por Romero (52) en 2022, está compuesto por 21 enunciados bien organizados, los cuales corresponden a tres dimensiones definidas: la Técnico-científica, Humana y Entorno. Para la evaluación del instrumento, los valores finales se distribuyen en tres niveles: alto (puntaje de 82-110), medio (puntaje de 52-81) y bajo (puntaje de 22-51). Su diseño sencillo y comprensible facilita su uso en estudios de campo del área de salud. Presenta propiedades psicométricas optimas que permite su uso en nuestra realidad.

Cuestionario de satisfacción de madres

El cuestionario, fue elaborado por Romero (52) en 2022, está compuesto por 18 enunciados bien organizados, los cuales están distribuidos en tres dimensiones definidas: Accesibilidad, Confort y Relación de Confianza. Para la evaluación del instrumento, los valores finales se distribuyen en niveles: alto (puntaje 82-110), medio (puntaje 52-81) y bajo (puntaje 22-51). Sus excelentes características psicométricas lo hacen adecuado para su aplicación en nuestro entorno. Además, su sencillez y claridad facilitan su uso en estudios de campo.

3.7.3. Validación

-Validez del cuestionario de calidad de atención de enfermería

En el estudio de Romero (52), hizo la validez del instrumento el cual fue evaluado mediante juicios de expertos, obteniendo un resultado del 88.3%, lo que lo calificó como válido y aplicable.

-Validez del cuestionario de satisfacción de madres

En el estudio de Romero (52) hizo la validez del instrumento que fue determinada a través de la evaluación de expertos, quienes dieron un resultado del 88.3%, considerándolo válido y aplicable.

3.7.4. Confiabilidad

-Confiabilidad del del cuestionario de calidad de atención de enfermería

En el estudio de Romero (52), realizado en 2022, se hizo la confiabilidad del instrumento empleando el Alfa de Cronbach, con un resultado de 0,77, lo cual permite generar resultados estables y consistentes, garantizando que las mediciones reflejen con precisión las características evaluadas, en síntesis el instrumento es fiable.

-Confiabilidad del cuestionario de satisfacción de madres

En el estudio de Romero (52), realizado en 2022, se hizo la confiabilidad del instrumento empleando el Alfa de Cronbach, que arrojó un valor de 0,78, indicando que el instrumento es fiable.

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

En este trabajo, el tratamiento de la información se iniciará con la revisión detallada de los datos obtenidos mediante las fichas correspondientes. Luego, la información será trasladada cuidadosamente a una matriz de información en el programa SPSS 26, diseñada conforme a los criterios previamente establecidos. El análisis se desarrollará en función de los objetivos e hipótesis planteados. En la etapa descriptiva se calcularán distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central, dispersión y otras estadísticas relevantes que permitan caracterizar las variables y dimensiones de interés. Posteriormente, se aplicará una prueba de normalidad para determinar el tipo de análisis inferencial a utilizar; de acuerdo con sus resultados, se aplicarán pruebas paramétricas o no paramétricas para contrastar las hipótesis. Finalmente, los hallazgos se mostrarán en tablas claramente organizadas y etiquetadas, constituyendo la base para la redacción de la sección discusión del estudio.

3.9. Aspectos éticos

Para llevar a cabo investigaciones clínicas o en el ámbito de la salud que involucren a personas, resulta indispensable cumplir con los lineamientos bioéticos. Resaltar la importancia de aplicar principios éticos básicos que garanticen la protección de los participantes y la idoneidad de los procedimientos. El principio de autonomía establece que cada individuo tiene derecho a decidir sobre su participación, lo cual se asegura mediante un consentimiento informado claro y completo. La no maleficencia exige evitar cualquier situación que pueda ocasionar daño o riesgo innecesario a los sujetos. La beneficencia se orienta a procurar el máximo provecho posible para los participantes, quienes deben conocer los

beneficios potenciales de su intervención en el estudio. Finalmente, la justicia busca que los resultados y ventajas generados se distribuyan con sentido de equidad, de modo que todos los participantes tengan las mismas oportunidades de acceso a los beneficios derivados de la investigación.

CAPITULO IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma de actividades

[illegible]

[illegible]

4.2. Presupuesto

MATERIALES	2025				TOTAL
	Abril	May	Jun	Jul	S/.
Equipos					
PC	3500				3500
Memoria digital	15		15	15	45
Materiales de escritorio					
Cuaderno	10			10	20
Hojas A4		25		25	50
Material Bibliográfico					
Copias		15	15	20	50
Impresiones	30	25	25	30	110
Otros					
Pasajes	20	30	30	20	100
Refrigerios	25	30	25	30	110
Llamadas	20	15	15	20	70
RRHH					
Digitador	400				400
Imprevistos*		250		250	500
TOTAL	4020	390	125	420	4955

REFERENCIAS

1. Organización de las Naciones Unidas. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades [sede Web]. New York-Estados Unidos: NU; 2023 [acceso 10 de diciembre de 2024]. [Internet]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
2. Organización Mundial de la Salud. Crecimiento infantil [sede Web]. Ginebra-Suiza: OMS; 2024 [actualizado en 2024; acceso 14 de octubre de 2024] [Internet]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/child-growth#tab=tab_1
3. Foldager S., Vilhjálmsen R., Ávik Persson H., Kristensson I. Parental satisfaction with paediatric care with and without the support of an eHealth device: a quasi-experimental study in Sweden. BMC Health Services Research [revista en Internet] 2021 [acceso 13 de abril de 2024]; 24(1): 1-11. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38195486/>
4. Peretomode E., Udo-Peretomode E., Diorgu Faith C. Mothers' Perception of Nursing Care of Hospitalized Children in Paediatric Ward in a 3rd Level Facility in South-South Nigeria. International Archives of Nursing and Health Care [revista en Internet] 2021 [acceso 12 de abril de 2024]; 7(2): 1-7. Disponible en: <https://clinmedjournals.org/articles/ianhc/international-archives-of-nursing-and-health-care-ianhc-7-156.php?jid=ianhc>
5. Beshir M., Tilahun T., Hordofa D., Abera G., Tesfaye W., Daba K. Caregiver satisfaction and its associated factors in pediatric wards of Jimma University Medical Center, Southwest Ethiopia. BMC Health Services Research [revista en Internet] 2022 [acceso 10 de setiembre de 2024]; 22(1): 1-11. Disponible en: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08459-4>
6. Jin I., Cho H. Factors influencing the quality of nursing care as perceived by mothers of

- hospitalized children in South Korea. *Child Health Nursing Research* [revista en Internet] 2021 [acceso 12 de noviembre de 2024]; 27(3): 266-275. Disponible en: <https://www.e-chnr.org/upload/pdf/chnr-27-3-266.pdf>
7. Mujica O., Sanhueza A., Carvajal L., Vidaletti L., Costa J., Barros A., et al. Recent trends in maternal and child health inequalities in Latin America and the Caribbean: analysis of repeated national surveys. *International Journal for Equity in Health* [revista en Internet] 2023 [acceso 17 de setiembre de 2024]; 22(1): 1-12. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10314462/pdf/12939_2023_Article_1932.pdf
 8. Madero K., Manrique Y., Guerrero A., Lopez L. Percepción de madres sobre la atención de enfermería en el servicio de crecimiento y desarrollo. *Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo* [revista en Internet] 2023 [acceso 17 de abril de 2024]; 25(1): 1-13. Disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/36530>
 9. Mamani S., Quispe B. Percepción de la calidad y satisfacción de madres sobre la atención de enfermería en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Puesto de Salud Pfullpuri Condepampa - Cusco 2020 [tesis titulación]. Julia-Perú: Universidad Peruana Union; 2022. [Internet]. Disponible en: <https://repositorio.upeu.edu.pe/server/api/core/bitstreams/8ea6f53b-eb93-44b7-9273-f0b1d1c21fc7/content>
 10. Apaza H. Calidad de atención y satisfacción de madres de niños menores de 5 años en el P.S Virgen de la Candelaria Puno-2023 [tesis titulación]. Puno-Perú: Universidad Privada San Carlos; 2023. [Internet]. Disponible en: http://repositorio.upsc.edu.pe/bitstream/handle/UPSC/534/Heylen_APAZA_CHALCO.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 11. Kruszecka A., Cepuch G., Gniadek A., Smoleń E., Piskorz K., Micek A. Selected predictors of

parental satisfaction with child nursing care in paediatric wards in Poland—Cross-sectional study. PLoS ONE [revista en Internet] 2021 [acceso 11 de setiembre de 2024]; 16(1): 1-18. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8604320/pdf/pone.0260504.pdf>

12. Adawudu E., Ansah S., Worae D., Agyei I., Baah B., Afaya A. Parent Satisfaction with Nursing Care Provided to Children at A Pediatric Unit in Ghana. International Journal of Nursing and Health Science [revista en Internet] 2024 [acceso 8 de setiembre de 2024]; 10(1): 1-10. Disponible en: <https://www.internationaljournalssrg.org/IJNHS/paper-details?Id=103>
13. Ojewale L., Akingbohunge O., Akinokun R., Akingbade O. Caregivers' perception of the quality of nursing care in child health care services of the University College Hospital, Nigeria. Journal of Pediatric Nursing [revista en Internet] 2022 [acceso 10 de setiembre de 2024]; 66(1): 120-124. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596322001373>
14. Persues A., Chirawurah D., Nyarko S., Abdul F., Baniakette A. Client's Satisfaction with Child Health Care Delivery in Tamale Teaching Hospital. Asian Journal of Pediatric Research [revista en Internet] 2023 [acceso 10 de noviembre de 2024]; 12(3): 5-12. Disponible en: <https://journalajpr.com/index.php/AJPR/article/view/240/471>
15. Mercedes L., Correa L. Percepción de madres sobre la atención de enfermería en el servicio de crecimiento y desarrollo [revista en Internet] 2023 [acceso 9 de noviembre de 2024]; 25(1): 1-8. Disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/36530/30084>
16. Huaytalla M. Calidad de cuidado enfermero y satisfacción en madres de niños de 3 años, consultorio de Cred, C.M.I - Magdalena, Lima – 2022 [tesis licenciatura]. Lima-Perú: Universidad Norbert Wiener; 2022. [Internet]. Disponible en:

[https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/9048/T061_46744462_T.pdf?
sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/9048/T061_46744462_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

17. Sanchez N. Calidad de atención de enfermería y satisfacción en madres de niños del servicio de crecimiento y desarrollo, Establecimiento I-3, Trujillo-2022 [Tesis maestría]. Trujillo-Peru: Universidad Cesar Vallejo; 2022. [Internet]. Disponible en:
[https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/101865/Sanchez_VNS -
SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/101865/Sanchez_VNS - SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y)
18. Montiel M., Salcedo N. Calidad de atención de enfermería y satisfacción de madres de niños menores de 2 años que acuden al control de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud de Ancahuasi, 2021 [Tesis licenciatura]. Trujillo-Peru: Universidad Tecnológica de los Andes; 2022. [Internet]. Disponible en:
[https://repositorio.utea.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7f61745d-34af-4fde-b5f6-
2f9865f8b6ff/content](https://repositorio.utea.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7f61745d-34af-4fde-b5f6-2f9865f8b6ff/content)
19. Castro K. Calidad de atención y satisfacción de los usuarios de los usuarios del servicio de Crecimiento y Desarrollo en Salud de Ancash, 2023 [tesis licenciatura]. Lima-Perú: Universidad César Vallejo; 2024. Disponible en:
[https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/141559/Castro_RKJ-
SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/141559/Castro_RKJ- SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
20. Yantas J. Calidad de atención de enfermería y su relación con la satisfacción de las madres en el control de crecimiento y desarrollo en niños menores de tres años en el Hospital Cayetano Heredia Lima 2023 [tesis licenciatura]. Lima-Perú: Universidad Norbert Wiener [Internet]. Disponible en:
[https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/11151/T061_25831612_T.pdf
?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/11151/T061_25831612_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

21. Akachi Y., Kruk M. Qualité des soins: Mesure d'un facteur négligé d'amélioration de la santé. Bulletin of the World Health Organization [revista en Internet] 2017 [acceso 18 de setiembre de 2024]; 95(6): 465-472. Disponible en:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5463815/pdf/BLT.16.180190.pdf>
22. Fundació Avedis Donabedian. Manual para equipos de mejora de calidad. Barcelona-España: Fundación Avedis Donabedian; 1996. 53 p.
23. Bhujang P., Dhananjay D. Quality In Healthcare. Rajhans Arcade-India: OrangeBooks Publication; 2024. 226 p.
24. Stavropoulou A., Rovithis M., Kelesi M., Vasilopoulos G., Sigala E. What Quality of Care Means? Exploring Clinical Nurses' Perceptions on the Concept of Quality Care: A Qualitative Study. Clinics and Practice [revista en Internet] 2022 [acceso 8 de setiembre de 2024]; 12(4): 468-481. Disponible en:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9326653/pdf/clinpract-12-00051.pdf>
25. Yusefi A., Sarvestani S., Kavosi Z., Bahmaei J., Mehrizi M. Patients' perceptions of the quality of nursing services. BMC Nursing [revista en Internet] 2022 [acceso 5 de setiembre de 2024]; 21(1): 1-11. Disponible en: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-022-00906-1>
26. Keenan-Lindsay L., Sams Ch., O'Connor C. Maternal Child Nursing Care in Canada. 2ªed. Canada: Elsevier Health Sciences; 2016. 1888 p.
27. Cusack L., Thornton K., Brytan J. Exploring responsibilities for delivering quality nursing care using the Healthcare Quality Framework; Quality care responsibilities. Collegian [revista en Internet] 2023 [acceso 5 de setiembre de 2024]; 30(1): 47-52. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1322769622001093>

28. Sitzman K., Watson J. *Caring Science, Mindful Practice*. 2ªed. Caring Science, Mindful Practice. New York - Estados Unidos: Springer Publishing Company; 2018. 52 p.
29. Burhans L., Alligood M. Quality nursing care in the words of nurses. *Journal of Advanced Nursing* [revista en Internet] 2010 [acceso 7 de setiembre de 2024]; 66(8): 1689-1697. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20557383/>
30. Saha P., Hossain M., Rana S. *Environment and Human Health*. Green Feather, editor. 2024. 175 p.
31. Mocumbi S., Högberg U., Lampa E., Sacoore C., Valá A., Bergström A. Mothers' satisfaction with care during facility-based childbirth: A cross-sectional survey in southern Mozambique. *BMC Pregnancy and Childbirth* [revista en Internet] 2019 [acceso 17 de setiembre de 2024]; 19(1): 1-14. Disponible en: <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-019-2449-6>
32. Bulto G., Demissie D., Tasu T., Demisse G. Mother's satisfaction with the existing labor and delivery care services at public health facilities in West Shewa zone, Oromia region, Ethiopia. *BMC Pregnancy and Childbirth* [revista en Internet] 2020 [acceso 13 de setiembre de 2024]; 20(1): 1-12. Disponible en: <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-019-2449-6>
33. Gulliford M., Figueroa J., Morgan M., Hughes D., Gibson B., Beech R., et al. What does «access to health care» mean?. *Journal of Health Services Research and Policy* [revista en Internet] 2002 [acceso 7 de noviembre de 2024]; 7(3): 186-188. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12171751/>
34. Wensley C., Botti M., McKillop A., Merry A. Maximising comfort: How do patients describe the care that matters? A two-stage qualitative descriptive study to develop a quality

improvement framework for comfort-related care in inpatient settings. BMJ Open [revista en Internet] 2002 [acceso 10 de seti. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239554/pdf/bmjopen-2019-033336.pdf>

35. Kolcaba K. Comfort Theory and Practice. Clinical Nurse Specialist. New York-USA: Springer Publishing Company; 2003. 264 p.
36. Birkhäuser J., Gaab J., Kossowsky J., Hasler S., Krummenacher P., Werner C., et al. Trust in the health care professional and health outcome: A meta-analysis. PLoS ONE [revista en Internet] 2017 [acceso 17 de setiembre de 2024]; 12(2): 1-13. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5295692/pdf/pone.0170988.pdf>
37. Watson N. Effective Communication for Nursing Practice. Londres-Inglaterra: SAGE Publication; 2024. 216 p.
38. Ministerio de Salud. Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para menores de 11 años [sede Web]. Lima-Perú: MINSA; 2024 [enero de 2024; acceso en setiembre de 2024]. [Internet]. Disponible en: <https://www.gob.pe/32588-control-de-crecimiento-y-desarrollo-cred-para-menores-de-11-anos>
39. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de 5 años [Internet]. Lima - Perú; 2017. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/191049/537-2017-MINSA.pdf?v=1593813764>
40. Richardson B. Pediatric Primary Care : Practice Guidelines for Nurses. 5ªed. Massachusetts-Estados Unidos: Jones & Bartlett Learning; 2023. 700 p.
41. Nightingale F. Notes on Nursing: Commemorative Edition. Pensilvania-Estados Unidos: Wolters Kluwer Health; 2018. 144 p.

42. Watson J. Human Caring Science. 2.^a ed. Estados Unidos; 2012. 31 p.
43. Donabedian A. La calidad de la atención médica: definición y métodos de evaluación. Ciudad de Mexico: Prensa Medica Mexicana; 1984. 194 p.
44. Parasuraman A., Zeithamil V. Servqual: A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perc - ProQuest. Journal of retailing [revista en Internet] 1988 [acceso 12 de setiembre de 2024]; 64(1): 1-12. [Internet]. Disponible en:
<https://www.proquest.com/openview/7d007e04d78261295e5524f15bef6837/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41988>
45. Patel S., Jena SR., Gupta A., Lathar P. Research Methodology Theory & Techniques. India: Xoffencer International Publication; 2023. 234 p.
46. Barroga E., Matanguihan G., Furuta A., Arima M., Tsuchiya S., Kawahara C., et al. Conducting and Writing Quantitative and Qualitative Research. Journal of Korean Medical Science [revista en Internet] 2023 [acceso 4 de marzo de 2024]; 38(37): e291. Disponible en:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37724495/>
47. Padmavathy R., Anand K., Kekare S., Cheepi P. Research Methodology Methods, Tools & Techniques. Estados Unidos: Academic Guru Publishing House; 2023. 208 p.
48. Albert F. Modern Research Design: The Best Approach To Qualitative And Quantitative Data. USA: Draft2digital; 2023. 88 p.
49. Allen-Duck A., Robinson JC., Stewart MW. Healthcare Quality: A Concept Analysis. Nursing Forum [revista en Internet] 2017 [acceso 2 de noviembre de 2024]; 52(4): 377-386. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5640472/>
50. Hosseinian M., Ajorpaz N., Manesh S. Mothers' satisfaction with two systems of providing care

to their hospitalized children. Iranian Red Crescent Medical Journal [revista en Internet] 2015 [acceso 6 de noviembre de 2024]; 17(2): 1-5. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4376982/pdf/ircmj-17-02-23333.pdf>

51. Nardi P. Doing Survey Research. A Guide to quantitative methods. 4ªed. Londres-Inglaterra: Editorial Routledge; 2018. 272 p.
52. Romero J. Calidad del cuidado enfermería y la satisfacción de las madres de niños menores de 5 años que acuden al consultorio CRED del Centro de Salud Huarupampa_Huaraz, 2021 [tesis titulacion]. Chimbote-Perú: Universidad Católica Los Angeles de Chimbote; 2022. 2022;2-3. Disponible en: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4848047?show=full>

Anexos

Anexo A. Matriz de consistencia

FORMULACION DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DISEÑO METODOL OGICO
Problema general ¿Cuál es la relación de la calidad de atención de enfermería con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña, Lima 2025? Problemas específicos ¿Cuál es la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión técnico - científica con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025? ¿Cuál es la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión humana con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025? ¿Cuál es la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión entorno con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025?	Objetivo general Analizar la relación de la calidad de atención de enfermería con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025. Objetivos específicos Determinar la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión técnico - científica con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025 Determinar la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión humana con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025 Determinar la relación de la calidad de atención de enfermería en su dimensión entorno con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025	Hipótesis general -Hi: Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025. -Ho: No existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025. Hipótesis específicas Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión técnico - científica y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025. -Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión humana y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025. -Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión entorno y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025	V1: Calidad de atención de enfermería V2: Satisfacción de madres	*El método de este estudio será hipotético – deductivo. *El tipo de investigación es aplicada *El presente estudio tendrá un enfoque cuantitativo *El diseño será no experimental

Anexo B. Instrumentos de recolección de datos

CUESTIONARIOS

I.PRESENTACIÓN

Saludos, soy egresada de enfermería y le invito a participar en la presente investigación, que busca indagar la calidad de atención de enfermería y satisfacción de las madres que acuden a este establecimiento de salud.

II.DATOS GENERALES DE MADRES INFORMANTES

Edad en años de la madre:

Estado civil:

Soltero:

Casado:

Conviviente:

Divorciado:

Viudo:

Nivel de instrucción:

Sin instrucción:

Primaria:

Secundaria:

Superior técnico:

Superior universitario:

Ocupación:

Ama de casa:

Trabajo eventual:

Trabajo estable:

Ama de casa y trabaja:

Edad en años del niño:

III.CUESTIONARIOS

Instrucciones:

Marque la respuesta que usted considere sea la mejor. No olvide responder todas las preguntas

A-Cuestionario de calidad de atención de enfermería

	TA	A	I	D	TD
1. La enfermera brinda la debida importancia a la toma de medidas de peso y talla, lo registra en el carnet de CRED explicándole el estado nutricional de su niño (a).					
2. La enfermera realiza higiene de manos antes y después de examinar a su niño(a).					
3. La enfermera evalúa a su niño(a) desde la cabeza a los pies y le brinda información sobre la evaluación.					
4. La enfermera evalúa el desarrollo psicomotor de su niño(a): lenguaje, comportamiento social, control de postura, motricidad y coordinación.					
5. La enfermera detecta alguna anomalía en su niño(a) y lo deriva a: odontología, nutrición, entre otros.					
6. La enfermera le brinda a su niño(a) y/o está pendiente de los exámenes de laboratorio según la edad que tenga: descarte de paracitos, descarte de anemia, test de Graham y le explica si le va a realizar algún procedimiento.					
7. La enfermera realiza el registro de la atención de su niño(a) en su respectiva historia clínica.					
8. El tiempo de espera para la atención de su niño(a) y el tiempo que dura la consulta en el consultorio de CRED, es adecuado.					
9. Su niño (a) recibe una atención de calidad y calidez de la enfermera.					
10. Se siente segura con los cuidados que brinda la enfermera a su niño(a).					
11. La enfermera le saluda y se despide de usted usando nombres propios al terminar la atención de su niño(a).					
12. La enfermera mantiene buena comunicación trata con respeto y brinda un trato amable durante la consulta con un tono de voz adecuada.					
13. La enfermera se muestra comprensiva y lo escucha					
14. La enfermera le brinda un trato amable.					
15. La enfermera le dio oportunidad para que usted le exprese algún problema con su niño(a).					
16. Se mantiene la privacidad durante la atención de su niño(a).					
17. El profesional de enfermería, muestra interés por la higiene y el orden.					
18. Las condiciones físicas y el ambiente del consultorio CRED son agradables, limpios y ordenados.					
19. El consultorio de CRED cuenta con los materiales y equipos necesarios para una adecuada atención a su niño(a).					
20. La enfermera le educa sobre los cuidados de su niño (a) en el hogar sobre: higiene, lavado de manos, alimentación según la edad, higiene oral, estimulación temprana, limpieza e higiene, ventilación de la casa, sueño y reposo, entre otros.					
21. La enfermera le da pautas de estimulación temprana según la edad de su niño(a), para que lo realice en casa.					

B-Cuestionario de satisfacción de madres

	TA	A	I	D	TD
1. La enfermera se preocupa por saber las razones de su inasistencia a los controles de su niño(a) y/o felicitar a Ud. Por haber acudido al centro de salud.					
2. La enfermera está pendiente de la seguridad de su niño(a) en el ambiente durante la atención.					
3. La enfermera brinda importancia a los problemas de conducta que tenga o tuviera su niño(a) como: irritabilidad, pasividad, indiferencia.					
4. La enfermera le aplica las vacunas a su niño de acuerdo a su edad a tiempo y le explica las reacciones adversas y de que protege cada vacuna.					
5. Considera que el tiempo que duró la consulta a su niño es adecuado.					
6. La enfermera brinda información con un lenguaje sencillo y tono adecuado.					
7. La enfermera mantiene el consultorio limpio y ordenado.					
8. La iluminación y ventilación del ambiente donde se encuentra el niño es adecuada.					
9. La Enfermera evita las corrientes de aire durante la atención.					
10. Durante el examen físico la Enfermera no deja expuesto al medio ambiente al niño por mucho tiempo.					
11. La Enfermera durante la atención cierra la puerta.					
12. La enfermera busca que exista un ambiente de privacidad.					
13. La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su niño.					
14. La enfermera le brinda una explicación sencilla de los procedimientos que realiza a su niño(a) y verifica si usted comprende las recomendaciones dadas para su niño(a).					
15. La enfermera durante la atención lo pone a su niño(a) en primer lugar, sin importar lo que pase a su alrededor.					
16. La enfermera es amistosa y agradable con usted y su niño(a).					
17. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con usted y su niño(a).					
18. El conocimiento asertivo de la enfermera le transmite confianza.					

Anexo C. Consentimiento informado

Instituciones: Universidad Privada Norbert Wiener

Investigadores:

-Apolin Matos Astrid Liliana

-Palma Rodríguez Aylin Tamara

Título: Calidad de atención de enfermería y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

Propósito del estudio

Lo invitamos a participar en un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener. El propósito de este estudio será analizar la relación de la calidad de atención de enfermería con la satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión técnico - científica y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

-Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión humana y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025.

-Existe relación significativa entre calidad de atención de enfermería en su dimensión entorno y satisfacción de madres usuarias de niños menores de 3 años que acuden a los controles de CRED en el Centro de Salud Breña Lima 2025 en el Centro de Salud Breña Lima 2025. Su ejecución ayudará a mejorar la atención en salud en estas áreas.

Procedimientos

Si usted decide participar en este estudio, se le realizará lo siguiente:

- Se brinda información sobre este
- Se solicitará el consentimiento informado
- Se le solicitará respuesta las preguntas del cuestionario

La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos y (*según corresponda, añadir a detalle*). Los resultados se le entregarán a usted en forma individual o almacenarán respetando la confidencialidad y el anonimato.

Riesgos

Su participación en el estudio no implica riesgo alguno para usted

Beneficios

Usted se beneficiará conociendo los resultados del estudio, así mismo de haber aspectos positivos estos irán directamente en su beneficio

Costos e incentivos

Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación.

Confidencialidad

Nosotros guardaremos la información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio.

Derechos del paciente

Si usted se siente incómodo durante el estudio, podrá retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna inquietud o molestia, no dude en preguntar al personal del estudio. Puede comunicarse con Apolin Matos Astrid Liliana (indicar número de teléfono: 948363701) o al comité que validó el presente estudio, Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, presidenta del Comité de Ética para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, tel. +51 924 569 790. *E-mail:* comite.ética@uwiener.edu.pe

CONSENTIMIENTO

Acepto voluntariamente participar en este estudio. Comprendo qué cosas pueden pasar si participo en el proyecto. También entiendo que puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Participante

Nombres:

DNI:

Investigador

Nombres:

DNI: